



Tea-Book

TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) :

AVALIAÇÃO , DIAGNÓSTICO E
ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS
EM 7 PASSOS.

Dr. Clay Brites

Pediatra e Neurologista Infantil pela ISCMSP

Pesquisador e Integrante do DISAPRE-UNICAMP

Mestrando em Ciências Médicas pela UNICAMP



NeuroSaber

TEA-BOOK

**TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) :
AVALIAÇÃO , DIAGNÓSTICO E ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS EM 7 PASSOS.**

Dr. Clay Brites
Pediatra e Neurologista Infantil pela ISCMSP
Pesquisador e Integrante do DISAPRE-UNICAMP
Mestrando em Ciências Médicas pela UNICAMP

1) INTRODUÇÃO

Nossa sociedade ainda engatinha e tem muito a evoluir quando falamos dos Transtornos do Espectro Autista (TEA). Esta sensação é real e marcante quando entrevistamos os pais destes pacientes e, ao mesmo tempo, olhamos em volta de nós mesmos nas clínicas públicas, nas escolas, nos ambientes comerciais, nos meios de transporte coletivo e, especialmente, nos familiares mais próximos destes núcleos familiares que conduzem estas crianças. A desinformação e a ignorância acerca do assunto ainda assustam e tornam urgente tomada de decisões no sentido de expandir o conhecimento das características clínicas, dos principais prejuízos sociais e da evidência do mau funcionamento destes pacientes para estudar, compartilhar, se comunicar e se sentir realmente fazendo parte de nossa existência.

Doenças como a dengue ou o diabetes, por serem difundidas e bem assimiladas pela nossa população há muitos anos, são atualmente bem compreendidas pelas pessoas leigas. Resultado de anos de cartazes, folders, medidas de prevenção empreendidas pela nossa sociedade organizada, estas doenças estão na língua do povo e comentadas frequentemente pelas pessoas quando alguém começa a ter seus sintomas. Não raro, os possíveis portadores correm para os postos de saúde na ânsia de confirmar ou não estes diagnósticos. “Se você faz muito xixi e bebe muita água, pode ser diabetes, meu filho” , disse uma vez uma senhora, avó de um paciente meu. Não é que ela tinha razão? Dias depois, os exames fecharam como diabetes e a criança iniciou seu tratamento a tempo de evitar maiores consequências.

A conscientização sobre problemas médicos é fundamental à sociedade para reduzir riscos gerados por problemas que, ignorados, podem resultar em caminhos sem volta. O acesso à informação oferece a disseminação de percepções para todos levando a um maior poder de observação por todos, independente da formação ou do nível cultural.

O TEA sofre ainda desta ampla e generalizada falta de informação no seio social e, pasmem, é exatamente isto que ainda impede que a maioria das crianças portadoras sejam precocemente tratadas.



Logo o TEA que precisa tanto da sua identificação o mais cedo possível para que se modifique, com efeito, os sérios prejuízos sociais e de funcionamento cognitivo que, se nada feito, desembocarão em permanentes dependências e impedimentos para o resto de suas vidas¹. Ademais, sua incidência na população tem aumentado de forma expressiva desde os anos 90 onde, para cada 1000 nascimentos, nascia uma criança com autismo e , hoje, esta proporção atinge 1:88. Nos EUA, na Ásia e na Europa, pesquisadores detectam uma prevalência atinge 1% da população. Na Coreia do Sul, tal cifra atinge 2,6%. Entre os gêneros, os meninos são os mais afetados numa proporção de 5:1 ¹ .

2) DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS TEA

Desde 1980, os TEA tem sido descritos no Manual de Transtornos Mentais (ou DSM) o qual tem expressiva importância nos parâmetros clínicos dos diagnósticos de transtornos neuropsiquiátricos em todo o mundo. No mais

recente, o DSM-5 , este descreve os TEA como, em geral, um distúrbio de desenvolvimento que leva a severos comprometimentos de comunicação social e comportamentos restritivos e repetitivos que tipicamente se iniciam nos primeiros anos de vida. Mas , o que isto significa?

Comparado a uma criança com desenvolvimento típico, normal, o Autismo é uma condição que severamente compromete a capacidade de se comunicar com os outros, de perceber acontecimentos compartilhados, de expressar o que sente ou pensa nas mais diversas situações, de utilizar as palavras de acordo com o contexto e estas características atrapalham gravemente o desenvolvimento global da criança.



Se não bastasse, a presença de “manias” , posturas ou atos repetitivos, rituais e interesses restritivos independente do público ou local em que a criança portadora esteja desarticula e fragmenta ainda mais a evolução de suas habilidades sociais e adaptativas nos desafios que o ambiente imprevisivelmente apresenta.

Muitas crianças com TEA tem distúrbios sensitivos e perceptivos visuais, auditivos e de sensibilidade na pele, levando a uma elevada sensibilidade para barulhos, ruídos específicos, luzes, agrupamento de pessoas e para determinadas cores e formas de ambientes. Por outro lado, podem ter baixa percepção para face humana, interpretação global das funções dos brinquedos e, enfim, ignorar momentos de controle social como regras e rotinas dos lugares onde visita.

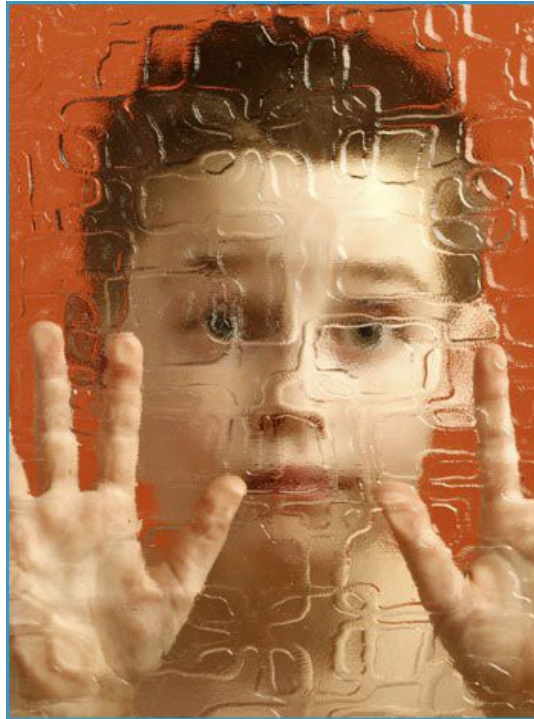
É muito importante reconhecer que este comportamento é irresistível, incontrolável, sem intencionalidade e que pode, se nada feito, em idades tardias, irreversíveis. Muitas crianças com autismo podem ter surpreendente evolução e até “sair” do espectro, mas isto depende de muitos fatores dentre eles o diagnóstico precoce, especialmente abaixo dos três anos de vida.



Até recentemente, muitos pediatras nem sequer conheciam aspectos básicos do perfil das crianças autistas resultando em identificações tardias. Muitos profissionais ainda temem revelar aos pais que seu filho pode tê-lo. Muitas crianças foram diagnosticadas tardiamente como resultado destas práticas nocivas. Nos EUA – país onde a saúde mental é encarada como doença crônica devastadora e com severas consequências emocionais e econômicas - os pediatras podem sofrer processos e perda de sua licença médica se for demonstrado que o mesmo não identificou sintomas autísticos em crianças até um ano e meio. Em nosso país, ainda engatinha a transmissão destes conhecimentos e a difusão do quadro clínico dos TEA o que já vem explicando a maior detecção desta condição em nosso meio.

Uma das maiores características clínicas dos TEA é o evidente prejuízo da linguagem expressiva, mais especificamente, a fala. Muitas destas crianças podem, após uma fase inicial de normalidade na aquisição da fala, sofrer regressões com redução do vocabulário, perda da fala de palavras anteriormente aprendidas, aparecimento de palavras sem significado e impróprios, repetições

de termos sem necessidade e sem função social. Outros podem ter atraso severo de fala e, quando iniciam, começam a falar palavras mal articuladas, jargões, repetições de termos e evolução pobre do vocabulário. Além disto, existe uma parcela de crianças afetadas que jamais falarão.



Se os TEA fossem um problema que se iniciasse na fase adulta, seus prejuízos talvez não fossem tão grandes. Mas o fato de se iniciarem na infância seu impacto no futuro do indivíduo e na vida de seus pares (família e escola) pode ser devastadora. Afeta a alimentação, o sono e o crescimento; desestrutura a evolução de saúde mental de seus pais; expõe o portador a mais infecções, acidentes e alergias; imputa prejuízos acadêmicos muito significativos podendo até inviabilizar a aprendizagem plena e a aquisição de habilidades na grande maioria dos casos afetados. Portanto, diagnóstico precoce, neste momento, é o caminho mais eficaz para diluir e reduzir a gravidade deste mosaico de problemas.

3) ALERTA: OS PRIMEIROS SINAIS NA INFÂNCIA



Uma criança normal adora *fixar seus olhos* nos olhos dos adultos logo nos primeiros 15 dias de vida e este ato se consolida até completar um mês. Nos primeiros três meses, ela inicia o *balbucio*, movimento de boca com emissão de sons tentando imitar e responder aos estímulos de seu cuidador. O *colo* de seus pais é aprazível e desejado a cada momento. A criança pede, chora, *procura* a presença de alguém quando deixada no berço ou carrinho de mão por muito tempo. Numa criança com TEA estes comportamentos podem não existir nos primeiros meses e é fundamental a conscientização para que a cultura da observação passe a estar presente nos pais e nos profissionais de saúde e educação que acompanham o desenvolvimento das crianças nos consultórios, nas escolas e nas creches.

“Doutor, ele não olhava para mim durante o aleitamento e eu achava muito estranho... Com meu outro filho, não era assim”. Com esta afirmação, esta jovem mãe, atestando por comparação, via que seu filho tinha algo estranho e não condizente com o que era normalmente esperado. “Via que ele era muito quieto, bonzinho, ficava horas acordado no berço sem chorar. Parecia não se importar. Ao pegar no colo, chorava muito e parecia estar tendo alguma dor. Ao levar no pediatra, este afirmava que era cólica e que logo passaria mas nunca passou...” E é isto mesmo. Esta mãe constatava que algo não estava bem na interação com seu filho e seu pediatra simplesmente interpretou-o como algo *fisiológico* sem se atentar em observar melhor o *comportamento*.

A ausência destes sinais: a fixação ocular, o balbucio, a busca pelo colo e a procura pelo cuidador nos primeiros três meses de vida são muitas vezes os primeiros alertas do espectro autista rondando o desenvolvimento da criança. A identificação dos mesmos só é possível se os profissionais de saúde e educação conhecerem profundamente o desenvolvimento infantil normal e terem como rotina o exame neurológico minucioso na fase da puericultura. Da mesma forma que temos o teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho e do coraçãozinho devemos nos habituar a exigir o “teste neurotípico” o qual não depende de aparelho mas sim de conhecimento clínico-observacional. Este “teste” auxilia também para identificar outros transtornos de desenvolvimento, encefalopatias perinatais, síndromes, doenças metabólicas neonatais e deficiências sensoriais. Em todos estes casos, quanto mais cedo, melhor!



Em muitos outros casos, pode acontecer o contrário: crianças irritadiças e extremamente chorosas ao serem colocadas para dormir. Noites sem sono por meses assolam seus pais e a criança. Ora trocam a noite pelo dia ora passam a dormir em fragmentos durante as eternas horas noturnas. A instabilidade do sono é quase uma constante nas queixas dos pais desde os primeiros anos e devem ser sempre valorizados.

Nos primeiros dois a três anos de vida, é muito importante observar como se faz a interação social da criança com seus pares ao seu redor. Atitudes como imitação, percepção do outro no brincar, permissão para compartilhar e flexibilizar atividades lúdicas de acordo com a demanda de seus amiguinhos e solicitar a atenção dos pais com gestos sociais (risos, piscadinhas, acenos, esticar os braços, etc.) são comumente aprendidas e expressadas pelas crianças mas muitas vezes ausentes ou discrepantes nos autistas. Em espaços públicos como creches, aniversários, casamentos e parquinhos é inevitável compará-la com outras crianças e constatar que “aquela” criança é diferente “daquela” e que suas atitudes e formas de interação social são estranhas ou ausentes... O mesmo se evidencia na observação do uso social de sua fala e na elaboração de sua linguagem as quais não correspondem aos outros e muitas vezes, sem ênfase e sem continuidade, se perde no espaço das brincadeiras, distantes ao seu interesse.



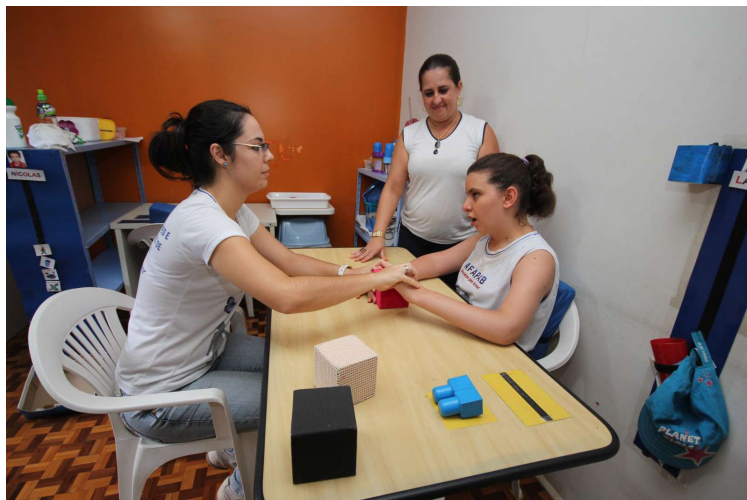
Mesmo em fase tão precoce, pode-se já se ver que esta criança tem perseverações e preferências difíceis de serem cessadas ou modificadas pelas circunstâncias. Estas se revelam na alimentação, nas atividades com os brinquedos, durante o uso do banheiro, na hora de dormir, em festas e reuniões de família onde aparecem por vezes objetos para os quais tem real obsessão. Deixam qualquer novidade para se voltarem ao de sempre. Perdem oportunidades para intensificarem a prática das mesmas coisas. O que fica evidente é uma seletividade excessiva que a prejudica e deteriora seu convívio com seus pais e parentes, constrange, inibe a busca pelo compartilhamento e, não raro, faz com sua família evite sair de casa.

Na investigação da possibilidade desta criança apresentar TEA é importante averiguar a história familiar de condições neuropsiquiátricas ou de transtornos de desenvolvimento. Outros fatores de risco envolvidas para o maior aparecimento de crianças com TEA são idade materna avançada na gestação (fenômeno cada vez mais comum e recorrente em nossos dias) e nascimento de baixo peso e/ou prematuridade. O uso de drogas lícitas ou ilícitas na gravidez também podem contribuir e é mister que os futuros pais se absteiam destas em caso de optarem por uma gestação. Ainda não é consenso na literatura internacional a associação de TEA com : alimentos ricos em glúten, lactose, conservantes; vacinas; venenos aplicados na agricultura; intoxicação ambiental por mercúrio e poluição. Em relação `as vacinas, a respeitável revista *The Lancet* se retratou e se desculpou em 2010 por ter publicado uma pesquisa equivocada,

em 1998, onde relacionava autismo com vacinas dadas dos 6 aos 9 meses. Nesta retratação, ela definitivamente descarta a relação destas com o aparecimento de sintomas autísticos por não haver evidências suficientes de causa-efeito³. Outra pesquisa ampla (CHARGE Study) onde se acompanhou sistematicamente 400 crianças entre 2 e 5 anos descartou a relação do autismo com contaminação por mercúrio.⁴



As causas do aparecimento do TEA nas crianças está hoje bem documentado como uma condição causada por fatores neurobiológicos, genéticos, com perfil de alto grau de herdabilidade em 80-90% dos casos. Evidências mostram que o cérebro destas crianças apresentam uma desorganização das colunas de neurônios que formam a arquitetura cerebral em várias áreas, especialmente as do lobo frontal, e também um volume cerebral acima do esperado para idade por prováveis atrasos ou interrupção das podas neuronais essenciais à neuroplasticidade programada a cada momento sensível de salto no desenvolvimento adaptativo⁵. Mesmo assim, existem estudos que mostram uma forte associação com outras causas ambientais como pré-eclâmpsia severa⁶ e intercorrências da prematuridade.



Existem atualmente várias escalas e *checklists* que orientam e organizam formas de observação deste comportamento na população pediátrica em geral. Estas escala podem ser utilizadas em creches, clínicas, escolas e podem ser aplicadas por cuidadores, professores, médicos em geral e profissionais que tratam ou convivem constantemente com crianças e adolescentes. Algumas delas: CHAT, M-CHAT, ADOS, ADI-R, CARS, etc.⁷

4) SINAIS E SINTOMAS DO TEA E OS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DO DSM-5

Os TEA apresentam 2 grandes características: problemas significativos de comunicação interativa-social e comportamentos repetitivos com interesses restritos². Nesta nova classificação diagnóstica, vemos que: 1) os problemas de linguagem foram incluídos nos problemas de comunicação e o Transtorno de Asperger foi retirado como termo de um tipo de autismo e absorvido pelos critérios atuais; 2) a Síndrome de Rett não faz mais parte integrante da classificação dos TEA por ter características motoras, corporais e ortopédicas mais se parecendo com uma doença degenerativa do que neuropsiquiátrica. 3) não se estabelece mais uma idade limite para o aparecimento dos sintomas

apenas ressaltando que devem ocorrer em fase precoce da vida; 4) que o aparecimento dos sintomas podem acontecer aos poucos, de forma irregular, até que se tornem incompatíveis com um funcionamento social ou adaptativo aceitáveis. Além destas observações atualizadas, estes critérios ajudam a auxiliar na avaliação de crianças com suspeita de problemas de desenvolvimento no que tange averiguar a possibilidade de autismo no âmbito das políticas de vigilância em saúde mental desde os primeiros anos de vida. Estes critérios servem como uma forma organizada e sistematizada de lembrar aos médicos e não-médicos os sintomas e sinais que devem chamar atenção caso a criança venha a desenvolver estas características e devem ser um elemento a mais no processo de investigação diagnóstica.

Comportamento Autista



Critérios Diagnósticos do DSM-5 para os TEA ² (tradução do autor)

A. Inabilidade persistente na comunicação social e na interação social nos mais variados contextos, não-justificados por atraso geral no desenvolvimento, e que se manifesta por 3 características a seguir:

1. Déficits na reciprocidade sócio-emocional;
2. Déficits nos comportamentos não-verbais de comunicação usuais para a interação social;
3. Déficits nos processos de desenvolver e manter relacionamentos;

B. Padrões restritos, repetitivos de comportamento, de interesses ou atividades manifestado por, pelo menos, 2 dos seguintes itens:

1. Fala, movimentos motores ou uso de objetos de forma repetitiva ou estereotipada;
2. Adesão excessiva a rotinas, rituais verbais ou não-verbais, ou excessiva resistência a mudanças;
3. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade e foco;
4. Hiper- ou hipo-reatividade para percepção sensorial de estímulos do ambiente ou interesse anormal e excessivo para estímulos senso-perceptivos.

C. Tais sintomas devem estar presentes em fase precoce da infância (mas podem aparecer aos poucos, em ordem ou sequência incompleta, progressivamente levando a problemas nas demandas sociais).

D. Sintomas, em conjunto, limitam ou impossibilitam o funcionamento no cotidiano.

Deve-se ressaltar que o quadro de autismo tem no geral estas características acima mas que se apresenta de forma heterogênea, ou seja, muito

particular em cada criança e que varia intensamente quanto ao grau de comprometimento, associação ou não com deficiência intelectual e com presença ou não de fala. Estas variações e o momento do diagnóstico definem a resposta aos tratamentos e se a evolução será favorável ou não.

O diagnóstico de TEA depende de fatores: 1) conhecer profundamente os TEA sabendo seus sinais e sintomas; 2) observar o comportamento da criança em casa, com os pais, na escola, no parque, enfim, em todos os ambientes que tenham crianças e adultos participando de preferência; 3) verificar fotos, vídeos, gravações realizadas na escola e em aniversários; 4) solicitar relatórios das escolas, creches e estes responderem com detalhes e com informações significativas (podendo até se utilizar de escalas de avaliação já citadas para facilitar e padronizar esta tarefa pois às vezes a escola nem sabe o que descrever e ressaltar); 5) conversar muito com os pais a fim de explicar bem o diagnóstico e a importância de tratá-lo.

No tocante ao último item, é comum, ao ouvirem que seu filho tem autismo, os pais não aceitarem e buscarem outras opiniões, o que é normal e aceitável dado a gravidade da notícia. Mas, infelizmente, por desconhecimento e desinformação e até por medo ou, ainda, por relutar a confirmar este diagnóstico, muitos profissionais negam ou omitem esta possibilidade aos pais o que pode retardar o tratamento e comprometer o futuro da criança de forma irreversível. É muito importante, portanto, que esta criança seja avaliada por equipe interdisciplinar ou por profissionais especializados onde a confiança no diagnóstico será confidencialmente maior e proporcionará o direcionamento mais rápido das prioridades terapêuticas.

Ainda é muito importante, por fim, considerar que o TEA – dependendo de caso a caso – associa-se muito frequentemente a outras condições neuropsiquiátricas como hiperatividade, agressividade, distúrbios de sono, problemas de coordenação motora, epilepsia, fobia social, deficiência intelectual, transtornos de linguagem, transtornos do espectro obsessivo-compulsivo e também a condições médicas, como: alergias alimentares, disfunções imunológicas, distúrbios gastrointestinais.

A variabilidade individual é marcante pois as causas envolvidas no desenvolvimento do TEA também são diversas e o curso de aparecimento e gravidade dos sintomas são múltiplos e complexos. Outrossim, pode variar também o nível intelectual, a presença ou não de fatores neuropatológicos (encefalopatias, paralisias cerebrais, sequelas hipóxico isquêmicas, deficiências áudio visuais, etc.) e o modo de instalação dos primeiros sintomas (súbito, lentamente progressivo ou regressivo).

5) ABORDAGEM TERAPÊUTICA DOS TEA

Com já se citou parágrafos acima, os TEA são condições heterogêneas, complexas, que ocorrem de forma particular com características diferentes de uma criança para outra. O tratamento, portanto, deve respeitar o que cada criança precisa e socorrer de acordo com seu “tipo” de autismo.



A abordagem terapêutica dos TEA , portanto, é vasta e composta de vários tipos de estratégias. O tratamento deve sempre ser multidisciplinar (quando se conduz as intervenções entre as disciplinas científicas) e transdisciplinar (quando, se transcende o tratamento para outras áreas como arte, religião e política) . Para indicá-lo(s), deve-se sempre considerar o momento do diagnóstico (idade e gravidade dos sintomas), nível de compreensão dos pais e

seu engajamento, status financeiro e presença ou não das possibilidades de tratamento próximo da família da criança com autismo. Didaticamente, dividiremos o manejo em 2 grandes grupos: 1) medicamentoso e 2) não medicamentoso. Em relação aos **tratamentos medicamentosos**, temos: uso de psicotrópicos (risperidona, aripiprazol, metilfenidato, anti-convulsivantes, naltrexone, bupropiona, clonidina, etc.), vitaminas, magnésio, anti-fúngicos e quelantes de metais pesados. Em relação aos **tratamentos não-medicamentosos**, temos: intervenções fonoaudiológicas específicas, restrições dietéticas (lactose/caseína e glúten), terapias comportamentais (ABA), educação estruturada específica (TEACCH), terapias de integração sensorial, equoterapia (ou até utilização de animais adestrados) e educação física.

Frente a todas estas possibilidades terapêuticas, é fundamental indicá-las respeitando-se protocolos, experiências, perfil da criança autista e se existem evidências científicas embasando a eficácia ou não de cada uma destas abordagens. Já pensou se os pais resolverem, inadvertidamente, buscarem todas estas formas de tratamento? Quanto gastarão? Quanto tempo dispensarão? Quanto sofrimento e sacrifício imporão ao seu filho e a si mesmos? E se estiverem perdendo tempo e dinheiro com estratégias pouco eficazes para o seu caso? Por outro lado, sempre encontraremos pais relatando que determinada forma de tratamento foi boa para seu filho mesmo que esta não tenha nenhuma pesquisa mostrando sua eficácia... Os pais precisam ler, conhecer, se aprofundarem e buscarem acesso a sites especializados e a profissionais ou grupos especializados que tem como objetivo principal conduzir a criança sem excessiva crença em estratégias infundadas. Deve-se tomar muito cuidado com propagandas de curas milagrosas na internet, críticas infundadas a medicações que podem auxiliar e repúdio às vacinas como se elas fossem responsáveis pelo autismo .

Assim, é importante conhecermos as evidências científicas para orientarmos estes tratamentos priorizando alguns passos e conduzindo esta família de forma a reduzir sofrimentos e sobrecargas desnecessárias. Daqueles tipos de tratamento citados acima, os únicos que tem evidência cientificamente comprovada de eficácia no manejo de crianças com TEA são as medicações

Risperidona e Aripiprazol para a redução dos sintomas de agressividade, estereotípias e hiperatividade; o metilfenidato para os sintomas de déficit de atenção; a terapia fonoaudiológica para promover estimulação de fala e linguagem em geral e as terapias comportamentais e estruturadas para a condução sistematizada nos diversos ambientes. As demais formas de tratamento ainda carecem de pesquisas e precisam de maior tempo de observação para realmente serem confiáveis para modificar os sintomas da criança e o sofrimento da família apesar de muitas delas tenha trazido significativa melhora para algumas crianças com autismo segundo a percepção de seus pais.

A) Terapia Comportamental (ou modelos de abordagem comportamentais)



O suporte psicoterápico tem como finalidade principal auxiliar no processo de estruturação do ambiente e dos comportamentos dos cuidadores no sentido de otimizar o acesso da criança a formas de comunicação e de contato adequado com as demandas do contato social e acadêmico. Historicamente, desde o início dos estudos para se entender o autismo e suas consequências, adotaram-se vários modelos e formas de intervir e restabelecer caminhos para estas crianças com o objetivo de incluí-las nos mais diferentes espaços e contextos.

A psicologia dispõe de vários meios de se atingir estes objetivos como métodos comportamentais, psicanalíticos e outros constructos, em geral,

associados ou complementares. Dentro desta análise, as evidências científicas vem mostrando a necessidade de, antes de tudo, direcionar a criança para *comportamentos mais aceitos socialmente* e induzir a criança a *reduzir os comportamentos socialmente inadequados*. Muitos modelos tem sido adotados para este fim com intervenções nos consultórios e nas atividades fora das clínicas, como escolas e creches.

Os modelos de intervenção mais amplamente adotados e analisados em pacientes com TEA são o TEACCH e o ABA. O **TEACCH** (em inglês, **T**reatment and **E**ducation of **A**utistic and related **C**ommunication handicapped **C**hildren) é uma forma de tratamento e educação para autistas e crianças com déficits relacionados à comunicação. É um programa que envolve as esferas de atendimento educacional e clínico, além de uma prática com abordagem psicoeducativa, tornando-o, por definição, um programa transdisciplinar. De origem teórica baseada no Behaviorismo e na Psicolinguística, consiste na adoção de refinamento de condutas, utilização de reforçadores e numa programação passo-a-passo associado a estratégias para compensar os déficits de linguagem e de comunicação dos TEA utilizando-se de recursos visuais para ampliar a capacidade de compreensão onde a percepção visual é geradora de comunicação⁸. Por sua vez, o ABA, a Análise do Comportamento Aplicada, é um método que traz da ciência comportamental - a qual é analisada a partir de eventos do ambiente e da interação do indivíduo com esta verificada em pesquisas de laboratório – experiências que serão desenvolvidas nos pacientes com TEA. O ABA se baseia em alguns princípios onde todo comportamento é mutável não importa o quê e em que intensidade determinado comportamento se apresenta; as atividades são realizadas por meios de reforço e punição; as mudanças devem ser empreendidas no cuidador e no portador de autismo onde *se eu melhorar, o comportamento autista de meu filho melhorará*; a intervenção tem como fiel da balança reforços positivos e negativos os quais variam de uma criança para outra e para cada tipo de comportamento inadequado, aplica-se um tipo de intervenção. Várias publicações internacionais tem constatado a eficácia do ABA no autismo tanto que as Academia Americana de Psiquiatria Infantil e da

Adolescência, a Academia Americana de Pediatria e a Academia Americana de Neurologia indicam o ABA como meio eficaz nos seus consensos e protocolos para TEA⁹.

B) Intervenção Fonoaudiológica



Os recursos de intervenção fonoaudiológica nos TEA são extremamente importantes especialmente nos primeiros anos de vida da criança e considerada como um dos meios mais eficazes de empreender mudanças significativas no transtorno quando indicada antes dos 3 anos de vida¹. O atraso de aquisição de fala e/ou a regressão da mesma em idades até os 3 anos de vida são sinais frequentes na suspeita do desenvolvimento do autismo e um dos eventos mais restritivos e que geram maior prejuízo na perspectiva futura da criança com TEA. Ademais, os problemas de fala desestabilizam muito e criam muita ansiedade aos pais.

A estruturação da linguagem de uma criança alicerça seu contato social e as vias de comunicação com o mundo, assim como permite construir códigos essenciais para a aprendizagem escolar, especialmente no que tange os fundamentos da leitura e da escrita. Estruturar a tempo a linguagem de uma

criança dentro dos parâmetros aceitáveis para um bom desenvolvimento global é fundamental e, no caso daquelas com TEA, extremamente significativo para sua adaptabilidade na vida social e escolar.

Várias evidências científicas atestam a importância capital de se intervir precocemente (antes dos 3 anos) na linguagem de crianças com TEA e a intervenção fonoaudiológica consiste em 2 grandes objetivos: aumentar o uso da comunicação verbal e melhorar o desempenho sócio-cognitivo. Artigos tem mostrado a maior resultado ao se montar estratégias diferenciadas a cada caso e em grupos de duplas.^{10, 11}

Além de formas de intervenção de linguagem para estimulação de fala por meio de associações da fala com os diferentes contextos, existem métodos de comunicação alternativa e/ou por figuras para aqueles casos que não adquiram a habilidade da fala¹².

C) Equoterapia



É um método terapêutico e educacional que consiste em utilizar o cavalo como instrumento para intervenções multidisciplinares em várias condições, entre elas o autismo onde ajuda nos processos de socialização e auxilia na diminuição de seus sintomas restritivos. O contato com o animal, com as pessoas do centro equestre, a presença de outros participantes ou cavaleiros ajudam na integração social do portador e contribui para as estratégias de inclusão.

Antes da criança ser encaminhada, ela deve passar por avaliação médica, psicológica e fisioterápica. Muitos autores tem ainda acrescentado que o processo equoterápico melhora o tonus muscular, postura, desenvolvimento perceptivo visuo-espacial, coordenação motora além de ajudar no emocional da criança por propiciar momentos de autonomia, auto-estima elevada e prazer no contato com o animal.¹³

Este processo auxilia na integração da criança com o ambiente escolar e faz com que ela reduza fobias e agressividade quando colocada em contato com outros contextos sociais.¹⁴

D) Terapias de Integração Sensorial



A Integração Sensorial é um método de tratamento que se baseia no desenvolvimento da capacidade de organizar sensações, por meio das funções dos sentidos: táteis, vestibular e proprioceptivos (eu e o meu corpo), para o propósito de executar atividades autodirigidas e significativas, que fornecem basicamente estimulação tátil, proprioceptiva e vestibular, por meio do contexto de brincadeiras que vão se tornando gradualmente mais complexas para promover respostas cada vez mais maduras e organizadas através do processo de organizar informação sensorial no cérebro, assim tendo como resultado novas aprendizagens e comportamentos. O paciente com TEA tem grande desintegração sensorial com *hipersensibilidade para alguns estímulos e reduzida para outros*. A integração sensorial auxilia no reequilíbrio de como perceber e de quanto perceber determinados estímulos ajudando a criança a refazer o modo como percebe e sente estes estímulos tornando-os agradáveis no cotidiano.

Normalmente conduzido por terapeutas ocupacionais, ela consiste na adoção de vários métodos de intervenção que se modificam e são indicados para cada caso.

E) Educação Física



A Educação Física tem sido amplamente empregada dentro do contexto de intervenção interdisciplinar no TEA. Suas atribuições vão desde organizar os movimentos das crianças até propiciar envolvimento em atividades sociais, compartilhadas e que envolvem regras e rotinas – pontos capitais para uma criança com TEA. O profissional, o educador físico, deve saber como lidar com autistas e desempenhar um papel de mediador nas atividades. Este método também ajuda na redução de peso (naquelas que são obesas até porque se utilizam de medicações que aumentam o apetite) e no reequilíbrio de funções do movimento corporal pois muitos autistas, por se restringirem muito a determinados ambientes, costumam ser muito sedentários.

F) Restrições Dietéticas e suplementação vitamínica



Restringir determinados alimentos ou específicos componentes da dieta de crianças com TEA são práticas cada vez mais veiculadas pela mídia e por determinados grupos que defendem tal estratégia para reduzir sintomas autísticos. No TEA, a conduta nutricional tem 4 grandes finalidades: 1) retirar componentes da dieta que seriam, hipoteticamente, causadores ou intensificadores do quadro autístico; 2) acrescentar componentes que

contribuiriam na redução dos sintomas; 3) restringir calorias para prevenir obesidade nas crianças com TEA que tomam medicações que aumentam o apetite; 4) evitar possíveis alergias já que é frequente crianças com autismo apresentar alergias alimentares ou respiratórias.

Alguns grupos e pesquisadores – mesmo ainda à revelia da ausência de comprovações científicas – tem postulado que o glúten e a caseína seriam responsáveis por gerar ou intensificar problemas autísticos nas crianças por alimentarem uma cadeia bioquímica que induziria a formação de componentes químicos “depressores” de determinadas funções cerebrais associadas à percepção social. Consequentemente, a retirada destes itens da dieta melhoraria os sintomas do TEA nos portadores. Como ainda carecem de evidências, o sacrifício de submeter a família a este tipo de tratamento ainda não é considerada justificável pela maioria dos experts em autismo.

A administração de Vitamina B12 e magnésio, por outro lado, tem sido apontada por várias pesquisas como benéfica para muitos casos de autismo e pode ser uma opção em casos específicos após análise em conjunto com o médico especialista.

G) Tratamento medicamentoso (psicofarmacoterapias)



A utilização de medicações psicotrópicas no TEA é muito importante e tem sido amplamente utilizada nas últimas décadas. As evidências científicas tem mostrado significativa melhora dos sintomas mais importantes do TEA com o emprego de determinadas classes de medicações. As classes mais prescritas

com boa aderência e melhora do quadro tem sido os antipsicóticos atípicos (Risperidona e Aripiprazol), psicoestimulantes (metilfenidato, atomoxetina), alfa-agonistas (clonidine) e inibidores seletivos de serotonina (sertralina, fluxetina, amitriptilina, nortriptilina)¹².

Efetivamente, e com a aprovação de órgãos relevantes de saúde pública (como o FDA, órgão responsável pela vigilância sanitária dos Estados Unidos e uma das instituições mais respeitáveis do mundo), a administração da Risperidona e do Aripiprazol tem sido indicadas como as de referência para o tratamento sintomático do TEA . Eles são eficazes para reduzir a agressividade, estereotipias e hiperatividade e auxiliam na redução dos sintomas “difíceis” proporcionando maior aderência social e adaptativa da criança na escola, nas terapias interdisciplinares, nos passeios `as áreas de lazer e lugares públicos.

Muitos pacientes com TEA só conseguiram ter avanços nas terapias muitas vezes após a introdução de determinadas medicações. O metilfenidato tem sido empregado para reduzir os sintomas de deficit de atenção e muitos trabalhos mostram que o uso da atomoxetina e da clonidina tem também contribuído positivamente. Sintomas de fobia social tem se reduzido com o emprego de antipsicóticos ou inibidores seletivos de serotonina. E por aí vai....

A decisão de medicar e com que medicar depende um boa conversa entre o especialista médico, a família, a escola e os profissionais não-médicos envolvidos com o tratamento da criança. Muitas vezes, uma medicação consagrada como boa pode não ser agradável ou eficaz em determinados pacientes. Em outras ocasiões, pode piorar a aprendizagem e a atenção nas terapias e na escola. Ainda, pode piorar o sono ou aumentar demais o apetite... Enfim, estas variáveis imprevisíveis devem ser conhecidas por todos e entendidas não como intoxicação ou “dopagem”, mas sim como efeito indesejável e reconhecido como possível e, portanto, passível de troca de medicação, redução de dose ou suspensão do fármaco. Por outro lado, não é raro pais e profissionais relatarem que somente após a medicação seu filho com autismo conseguiu avançar na fala, estruturar melhor suas rotinas e se alfabetizar.

6) CONSIDERAÇÕES À FAMÍLIA



Os pais de um autista na maioria das vezes se vêem em uma situação de desespero, insegurança e culpa ao receberem o diagnóstico. Comumente, procuram segunda, terceira, quarta opinião na esperança de que algum profissional diga o contrário. Nesta peregrinação, ouvem os familiares os quais desdenham da má notícia falando que aquele médico é louco ou que não sabe muito e devem procurar outros. Em alguns casos, o próprio pediatra ou fonoaudiólogo da criança não acredita desencorajando-os a procurar o devido tratamento. Ou ainda, caem na conversa da internet leiga ou de charlatões prontos para enganá-los com receitas milagrosas ou que produzem, de algum modo, falsas esperanças...

Neste processo, quase ninguém observa o sofrimento destes pais: as noites em claro com o filho que não dorme, a vergonha e o constrangimento de ir no shopping ou em reuniões familiares pois ele não pára e agride os outros, o esfriamento da relação a dois e abstinência sexual gerada por dias cansativos e as noites mal dormidas, com a auto-estima e a energia em frangalhos.



“ Há meses e até anos que não vou na manicure e não saio mais de casa pois estou sempre em alerta com meu filho. Eu o amo, mas não sei até quando vou aguentar! ” Esta mãe chorou em meu consultório e muitas choram escondidas pois não revelam seu sofrimento com medo de serem mal interpretadas pelos seus parentes. Muitos pais cuidarão desta criança para o resto de suas vidas.

Portanto, recomendo que os pais de pacientes com autismo, ao se deparar com o diagnostico, tomem sempre as seguintes medidas: 1) procurem se informar, pedir ajuda a organizações não-governamentais relacionadas a este tema, troquem idéias com quem já está nesta caminhada a mais tempo; 2) entrem nas redes sociais e busquem *fan pages* no Facebook de pais e grupos que compartilham experiências pois a vivência do outro pode ser genuína e dar dicas de como conduzir o seu filho mesmo num contexto diferente; 3) não tenha medo de medicações faixa preta ou vermelha pois estas podem ser fundamentais para a qualidade de vida em sua casa e permitir que seu filho avance mais do que se não tivesse medicado; 4) fique sempre alerta consigo e com seu parceiro acerca de seu comportamento e de sua vida conjugal pois viver com uma criança com dificuldades já é difícil, imagine então num casamento `a deriva.

Os pais de autistas ficam mais facilmente estressados, com maior risco de transtornos de ansiedade, de sono e de depressão e são mais propensos ao divórcio e ao naufrágio social e na carreira profissional. Se a medicina está

ciente disto, cuidem-se e se previnam contra estes males no seu cotidiano. Este e-book foi cuidadosamente escrito para server como um guia básico de informação e para auxiliar nos primeiros passos do longo tratamento.

7) COMENTÁRIOS FINAIS



O TEA é uma condição severa ao desenvolvimento global da criança com efeitos para todo o seu ciclo restante de vida e no qual o diagnóstico e a intervenção precoce deve ser sempre a regra! A condução terapêutica é sempre multidisciplinar e de difícil evolução pois há em seu bojo clínico e comportamental uma gama de complexas variáveis sociais, econômicas, médicas e individuais. O acesso ao conhecimento generalizado e ao suporte adequado para a avaliação e manejo do TEA é um direito e deve ser encarado como uma obrigação por qualquer organização pública ou privada que se destina a promover saúde e pleno desenvolvimento à harmonia familiar permitindo acesso a qualquer um independente de seu credo ou classe sócio-econômica.

BIBLIOGRAFIA

- 1) American Academy of Pediatrics - Committee on Children with Disabilities (2000-2001). The Pediatrician's Role in the Diagnosis and Management of Autistic Spectrum Disorder in Children . American Academy of Pediatrics 2001; 1221-1226.
- 2) American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of & mental disorders. 5th ed. Arlington VA: American Psychiatric Association; 2013; 50-59.
- 3) Retraction — Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. *Lancet* 2010; 375: 445.
- 4) Hertz-Picciotto I, Green PG , Delwiche L , Hansen R, Walker C, Pessah I. Blood Mercury Concentrations in CHARGE Study Children with and without Autism. *Environmental Health Perspectives* 2010; 118(1): 161- 166.
- 5) Stoner R, Chow ML , Boyle MP, Sunkin SM, Mouton PR, Roy S, et al. Patches of Disorganization in the Neocortex of Children with Autism. *N Engl J Med* 2014; 370:1209-1219
- 6) Walker CK, Krakowiak P, Baker A, Hansen RL, Ozonoff S, Hertz-Picciotto I. Preeclampsia, Placental Insufficiency, and Autism Spectrum Disorder or Developmental Delay. *JAMA Pediatr.* 2015;169(2):154-162. doi:10.1001/jamapediatrics.2014.2645
- 7) Sato FP. Validação da versão em português de um questionário para avaliação de autismo infantil [Dissertação]. São Paulo (SP): Universidade de São Paulo; 2008.

- 8) Kwee CS. Abordagem Transdisciplinar no Autismo: O Programa TEACCH [Dissertação]. Rio de Janeiro (RJ): UERJ; 2006.
- 9) Smith T. Behavior Analysts Can Be Interdisciplinary too: a Review of Durand's Autism Spectrum. *Journal of Applied Behavior Analysis* 2014; 47 : 866–879
- 10) Fernandes FD, Cardoso C, Sassi FC, Amato CLH, Sousa-Morato PF. Fonoaudiologia e autismo: resultado de três diferentes modelos de terapia de linguagem. *Pró-Fono Revista de Atualização Científica*. 2008 out-dez;20(4):267-72.
- 11) Baixauli-Fortea I, Roselló-Miranda B, Colomer-Diago C. Relaciones entre trastornos del lenguaje y competencia socioemocional. *Rev Neurol* 2015; 60 (Supl 1): S51-S56
- 12) Fortea-Sevilla MS, Escandell-Bermúdez MO , Castro-Sánchez JM, Martos-Pérez J. Desarrollo temprano del lenguaje en niños pequeños con trastorno del espectro autista mediante el uso de sistemas alternativos. *Rev Neurol* 2015; 60 (Supl 1): S31-S35
- 13) FREIRE, H. B. G. Estudo de caso: equoterapia com uma criança portadora de distúrbio autista atípico. Programa de equoterapia da Universidade Católica Dom Bosco. Campo Grande – MS, 2002. Disponível em: <<http://equoterapia.org.br/site/trabalhos.php?id=77>>.
- 14) FREIRE, H. B. G. Equoterapia teoria e técnicas: uma experiência com crianças autistas. São Paulo: Vetor, 1999.